

УДК: 616.6

М.А.Асимов, Ф.А.Багиярова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

## Психотерапия табачной зависимости методом самосовладания по Асимову в профилактике возникновения онкологических заболеваний

*Аннотация. На современном этапе развития психо-социальной помощи населению на уровне ПМСП в РК, становится актуальным оказание качественной медико-психологической помощи населению, в частности в вопросе профилактики и лечения табачной зависимости, предупреждения развития онкологических заболеваний связанных с курением. Медицинские психологи, нуждаются в новых эффективных методиках и подходах психокоррекции никотиновой зависимости. В статье отражены наиболее распространенные подходы лечения табачной зависимости и предложена новая методика «Самосовладание по Асимову», которая может быть использована как инструмент в работе медицинского психолога в психокоррекции или психотерапии табачной зависимости.*

*Ключевые слова: онкопсихология, медицинская психология, психотерапия табачной зависимости, профилактика онкозаболеваний, Самосовладание по Асимову.*

По данным МАИР, в 2000 г. злокачественными опухолями в мире страдало 10 млн человек. По тем же оценкам, в 2000 г. в мире от рака умерли 8 млн человек. Основными факторами риска для развития рака легкого, полости рта и глотки является курение. Курение — главная причина рака легкого (РЛ). По разным данным, 85—95% РЛ у мужчин и 65—80% РЛ у женщин этиологически связаны с курением [1]. РЛ можно отнести к социально значимым болезням, при которой основной причиной возникновения является курение. Соответственно профилактика курения является основным эффективным методом снижения заболеваемости и смертности от этого заболевания.

По данным 5-го Национального исследования 2012 года, проведенного НЦ ПФЗОЖ по заказу МЗ РК, распространенность табакокурения среди опрошенного взрослого населения в РК составила 26,5%, пассивному курению подвергаются 62,2% респондентов, из числа курящих респондентов никогда не бросали курить 25,9%, ежедневно курят сигареты 20,3% опрошенных, курят не каждый день 8,3%. Жертвами табачной эпидемии, как правило, становятся люди трудоспособного возраста — мужчины 18-55 лет и женщины репродуктивного возраста 15-49 лет. Особую тревогу вызывает рост приобщения к табакокурению подростков и молодежи [2].

Одним из эффективных практических механизмов профилактики табакокурения, употребления табачных изделий и оказания помощи при отказе от курения, являются антитабачные центры и социально-психологическая служба на базе региональных центров ФЗОЖ, ФАП и ПМСП РК.

В связи с этим, развитие психо-социальной помощи населению на уровне ПМСП в Республике Казахстан, со-

гласно Государственной программе развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015гг, становится актуальным [3]. Необходимо совершенствовать качество медико-психологической помощи населению, в частности в вопросе профилактики и лечения табачной зависимости. Медицинским психологам необходимо активно участвовать в профилактике, психогигиене и психокоррекции табачной зависимости. При этом есть необходимость поиска новых и доступных психологических подходов при данной работе на уровне ПМСП.

Современный подход в терапии табачной зависимости — это комплекс мер, направленных на снижение патологического влечения к табаку, предупреждение и лечение синдрома отмены, купирование сопутствующих психологических и соматических проявлений, возникающих в период отказа от курения. Механизм влияния курения табака на здоровье сложен. Хотя табакокурение не является причиной возникновения соматических заболеваний, это — фактор, меняющий течение основных заболеваний и способствующий переходу предболезни в болезнь. Важно, проводить профилактические меры, для предупреждения рецидива курения [2].

Индивидуальный подход в лечении табачной зависимости с учетом дифференцирования клинических проявлений, требует от медицинских психологов сотрудничества с врачами-терапевтами, психиатрами, невропатологами, кардиологами, иглорефлексотерапевтами и другими медицинскими специалистами.

Специалисту, занимающемуся проблемами табакокурения, важно учитывать, что курильщики проходят через несколько фаз подготовки к отказу от курения, что помогает определить готовность пациента бросить курить и использовать фокусные подходы психокоррекции и способов поддержки пациента.

- Первая фаза — предварительная. Пациент окончательно еще не решил бросить курить. В этой стадии чрезмерное настаивание на том, чтобы пациент прекратил курить, чревато обратной реакцией со стороны пациента в виде сопротивления. Врачу следует просто предоставить пациенту информацию о рисках продолжения курения.

- Вторая фаза — размышление. Пациент думает, о том, чтобы бросить курить, но все еще не готов сделать это. На этой стадии курильщик еще договаривается с собой прекратить курение.

- Третья фаза — подготовка, пациент действительно предпринимает попытки бросить курить.

- Четвертая фаза — активная. Это фаза действия: пациент меняет свои действия и действительно не курит.

• Пятая фаза – поддержки. Наконец, после успешного отказа от курения пациент пытается воздерживаться от сигарет [4].

Основные подходы в помощи отказа от курения, направлены на поддержание уверенности в правильности сделанного выбора, установки на отказ от курения, на выработку отвращения к табаку и на снижение абстиненции, то есть уменьшение дискомфорта и негативных симптомов, связанных с отказом от курения.

Процесс психокоррекции табачной зависимости включает 6 этапов:

- Подготовительно-разъяснительная беседа;
- Ослабление (подавление) синдрома отмены;
- Лечение сопутствующих психопатологических расстройств;
- Коррекция патологического стереотипа в поведении курильщика табака;
- Адаптация к некурительному стилю поведения.
- Осознание невозможности («опасности рецидива») возобновления курения (самоконтроль личности).

Одним из традиционных методов, лечения табачной зависимости - позитивная психотерапия. При психокоррекции табачной зависимости, на всех этапах лечения и профилактики, психолог уделяет внимание рациональной, разъяснительной психотерапии, направленной на устранение неправильных представлений о болезни, осознания наличия болезненной зависимости от никотина, усиление возможностей личности контролировать состояние абстиненции. Психотерапия может осуществляться как в директивной, так и недирективной форме. Выбор методического подхода определяется чертами личности курильщика и активного вовлечения самого пациента в процесс лечения [5].

В некоторых случаях эффективнее применение рациональной психотерапии, которая осуществляется в форме целенаправленной беседы с пациентом, при которой у него формируются и закрепляются следующие основные установки: основные доводы и причины для отказа от курения; курение не просто привычка, а зависимость, требующая определенных усилий и приемов для ее преодоления; главное условие успешного преодоления табачной зависимости – наличие у пациента твердо принятого решения бросить курить [6].

Также популярна поведенческая терапия, которая заключается в обучении пациента поведенческим приемам, которые помогают самостоятельно преодолеть табачную зависимость. При этом необходимо: обсудить с пациентом, в каких ситуациях у него возникает наиболее сильное желание закурить и определить, как избегать и преодолевать эти ситуации путем отвлечения на другие занятия или изменения в распорядке дня; следует избегать общения с курильщиками особенно в ситуациях, когда они курят или могут закурить; следует сообщить окружающим и близким, что Вы бросили курить; обсудить и определить приемы для погашения рефлекса со стороны полости рта; рекомендовать активизировать физическую нагрузку; больше пить жидкости, исключая алкоголь и кофе; максимально, занять свободное время, приветствуется любой вид занятия и развлечения; при внезапно возникшем остром желании закурить, следует отвлечь себя любым родом деятельности, сменить об-

становку; делать дыхательные упражнения, с задержкой дыхания на 10-20 секунд и сюда же можно подключить аутогенную тренировку [7, 8].

Несмотря на множество комплексных подходов в терапии табачной зависимости, эффективность методов по некоторым источникам составляет 47%, но к концу года возобновляют курение до 85% пациентов, по данным М. Gmur, A. Fschopp (1989) [6, 9]. Эти данные обосновывают необходимость поиска и использования новых, более адаптивных и эффективных методов лечения табачной зависимости.

В процессе поиска эффективных методов профилактики и психотерапии, кафедрой коммуникативных навыков, психотерапии и психологии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, разработан и запатентован новый метод психокоррекции или психотерапии «Самосовладение по Асимову», целью которого является обучение самосовладающему поведению личности, ориентированной на выработку новых форм поведения.

Данная методика состоит из шести последовательных ступеней направленных на активизацию способности самого человека научиться справляться с проблемным поведением. На каждой ступени клиент (пациент) при проведении психокоррекции по данной методике прорабатывает свои проблемные ситуации, внутриличностные конфликты, продолжая обучаться использованию данного метода. Коротко можно представить эту методику, на примере данной проблемы, следующим образом.

Первая ступень предусматривает понимание о психическом состоянии и его составляющих - чувства, ощущение и образы. На примере данной проблемы желание закурить это есть Состояние, которое состоит из чувства тревоги (или волнения или раздражения – зависит от соответствующего образа), ощущения першения в горле и соответствующего образа.

Вторая ступень, это работа с наведенными образами и обучение дифференциации и вербализации психического состояния в режиме работы с наведенными образами. На примере данной проблемы: в образах как, пачка сигарет и других, отображающих процесс курения и соответствующих чувствах, соответствующих ощущениях, пациент прослеживает весь процесс курения, при этом управляя своим состоянием – прослеживая образы, чувства и ощущения, отживая или проживая свои желания курить, виртуально начинает курить.

Третья ступень, клиент осваивает методику работы со свободными образами при закрытых глазах и учится прослеживать психическое состояние через «модель цикличной (непрерывной) динамики «Чувство – Ощущение – Образ». На примере данной проблемы: спонтанно прослеживает ситуации когда появляется состояние желания закурить и виртуально курит. Виртуальное курение приводит к угасанию желания, к тому что пациент научается справляться с желанием.

Четвертая ступень, это работа со свободными образами при открытых глазах клиента и умение вербализовать (словесно выражать) чувство и ощущение, соответствующее свободному образу при открытых глазах. Спонтанно прослеживает свои состояния через образы, чувства и ощущения, но при открытых глазах, виртуально курит, но уже может не доходить до состояния жела-

ния закурить, вследствие тренировок предыдущих шагов - угасания.

Пятая ступень, управление психическим состоянием в режиме *invitro*. Клиенту предлагают сигареты и зажигалку и предлагают совершать определенные действия имитирующие процесс курения, при этом прослеживая свои образы, чувства и ощущения. Необходимо вслух проговаривать свои наблюдения отмечая образы, чувства и ощущения.

И шестая, заключительная ступень – Самосовладание: экологическое поведение и творческая самореализация. Эта ступень направлена на выработку в клиенте способности к выражению, а не проявлению, своих чувств и мыслей при взаимодействии с окружением. Таким обра-

зом выработать экологическое поведение [10].

Методика «Самосовладания по Асимову» рассчитана на 6-8 встреч и состоит из прохождения вышеописанных шести ступеней, где курильщик обучается понимать, различать и осознавать свои чувства, мысли-образы и ощущения. Данной методике обучаются курсанты психологи и психотерапевты на курсах повышения квалификации.

В целом успех борьбы с курением будет зависеть не только от того, какое значение придает ему сам медицинский работник, психолог или психотерапевт, но и настроенность и мотивация пациентов. Всесторонняя поддержка значительно увеличивают вероятность успеха.

#### Список литературы

1. Мукерия А. Ф., Заридзе Д. Г. Эпидемиология и профилактика рака легкого // *Вестн. РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН.* - 2010. - №3. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/epidemiologiya-i-profilaktika-raka-legkogo>.
2. Тулегалиева А.Г., Баттакова Ж.Е., Мукашева С.Б., Шумилина Л.Н. Организация деятельности антитабачных центров в Казахстане.- Алматы, 2013. - 38 с.
3. КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.04.2012 г.).
4. Асимов М.А. Современные подходы к терапии табачной зависимости.- КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2011. [Http://kaznmu.kz/press/wp-content/uploads/2011/09/Особенности-психотерапии-табачной-зависимости.pdf](http://kaznmu.kz/press/wp-content/uploads/2011/09/Особенности-психотерапии-табачной-зависимости.pdf).
5. Тулегалиева А.Г., Баттакова Ж.Е., Мукашева С.Б., Шумилина Л.Н. Организация деятельности антитабачных центров в Казахстане.- Алматы, 2013. - 38 с.
6. Friedman L.S., Fleming N.F., Roberts D.H., Hyman S.E. (eds.). *Source book of substance abuse and addiction.* - Baltimore: Williams & Wilkins, 1996. - 348 p.
7. Шарахов Ю.А. Психотерапия в комплексном лечении табачной зависимости. М. - 1999. - 226 с.
8. Федоров А.Р., Когнитивно-поведенческая психотерапия, 2012.
9. Tanja C. Rothrauff phd1 and Lillian T. Counselors' Knowledge of the Adoption of Tobacco Cessation Medications in Substance Abuse Treatment Programs // *Eby phd1,2 Article first published online: 12 NOV 2010, DOI: 10.1111/j.1521-0391.2010.00095.x*.
10. Асимов М.А., Мадалиева С.Х., Кожамжарова К.О. и др. Метод личностно-ориентированной индивидуальной и групповой психотерапии: «Самосовладание по Асимову», Алматы, 2012.

#### Тұжырым

М.А.Асимов, Ф.А.Багиярова

**Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ Асимов бойынша «Өзін жеңу» әдісінің темекі тәуелділігіне қарсы психотерапияның онкологиялық аурулардың алдын-алу әрекеті ретінде**

ҚР АМСК деңгейінде бүгінгі таңда тұрғындарға психосоциалдық көмек көрсету, сапалы медициналық-психологиялық көмек көрсету ең өзекті мәселе болып отыр. Соның ішінде, темекіге тәуелділікті емдеу және алдын – алу, онкологиялық аурулардың дамуы темекіге тәуелділікке байланысты екенін ескерту. Медициналық психологтар никотинге тәуелділік психокоррекциясының жаңа тиімді әдістері мен тәсілдерін қажет етеді.

Мақалада темекіге тәуелділікті емдеудің біршама кең таратылған тәсілдері көрсетілді және «Асимовтың өзін-өзі жеңу» жаңа әдісі ұсынылды. Бұл әдіс мүмкін темекіге тәуелділік психокоррекциясы және психотерапиясының медициналық психологтар жұмысындағы негізгі құралы ретінде пайдаланылады.

Түйінді сөздер: онкопсихология, медициналық психология, темекі тәуелділігінің психотерапиясы, онкологиялық аурулардың алдын-алу, Асимов бойынша «Өзін жеңу»

#### Summary

M.A.Assimov, F.A.Bagiyarova

**Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology Psychotherapy of tobacco addiction by "Coping by Assimov" as a cancer prevention**

At the present stage of development of psychosocial assistance at the level of primary health care in the Republic of Kazakhstan, the provision of quality medical and psychological assistance to the population becomes relevant, in particular in the prevention and treatment of tobacco dependence, and in the prevention of cancer associated with smoking. Clinical psychologists are in need of new effective methods and approaches in the psycho-correction of nicotine addiction. The article describes the most common approaches for the treatment of tobacco dependence and the proposed new method "Coping by Assimov", which can be used as a tool for the clinical psychologist in psycho-correction or psychotherapy of tobacco dependence.

Keywords: psycho-oncology, health psychology, psychotherapy of tobacco addiction, cancer prevention, Coping by Assimov